

Panorama da Prática Psicológica

Condições administrativas e financeiras do exercício da clínica privada no Brasil e comparação internacional

Pesquisador responsável	Leandro Oliveira — economista e contador, pós-graduado em Gestão
Realização	Levantamento independente, sem vínculo institucional. Custeado pela Produtize Produtos e Serviços Inteligentes LTDA — CNPJ 48.417.292/0001-99
Contato	leandro@sessoes.com.br · +55 11 91911-1050
Pré-registro	Open Science Framework — DOI [a preencher antes da coleta]
Período de coleta	[mês] a [mês] de 2026
Financiamento	Recursos próprios; sem financiamento externo, público ou de terceiros

1 · Justificativa

A produção sobre o exercício profissional da Psicologia no Brasil concentra-se em três frentes: o perfil da categoria e sua inserção no mundo do trabalho, com destaque para o CensoPsi 2022 (Bentivi, Porto & Dias, 2022; Costa & Oliveira, 2025); a atuação em políticas públicas e serviços de saúde; e o abandono e a adesão ao tratamento na perspectiva clínica.

Não foi localizado, em busca sistemática, nenhum levantamento nacional sobre as condições administrativas e financeiras do exercício da clínica privada — frequência e destino de sessões não realizadas, práticas de cobrança e de política de faltas, adequação de honorários à referência da categoria, tempo despendido em atividades não assistenciais, e cumprimento de obrigações fiscais recentes, como o Recibo Eletrônico de Serviços de Saúde, obrigatório desde 1º de janeiro de 2025 (IN RFB nº 2.240/2024).

A lacuna é relevante por três razões documentadas:

- **A modalidade autônoma concentra parte expressiva da categoria.** O CensoPsi 2022 registra que **35,5% dos respondentes trabalham exclusivamente como autônomos** e que **71% mantêm mais de um vínculo** (Bentivi, Porto & Dias, 2022, p. 165), indicando que a sustentabilidade da prática privada é questão material para fração ampla das profissionais.
- **Há distância documentada entre a referência de honorários e a prática relatada.** A tabela CFP/Fenapsi, vigente desde 1º de junho de 2024, situa a psicoterapia individual entre **R\$ 213,93 e R\$ 366,76**, com média de R\$ 309,75. Relatos públicos de mercado situam a prática comum em faixa inferior. A magnitude e a distribuição dessa distância não foram medidas.
- **Uma obrigação fiscal nova incide sobre a categoria sem que se conheça o grau de adesão.** A emissão do Recibo Eletrônico de Serviços de Saúde é obrigatória desde 2025, sob multa de R\$ 100 por mês-calendário ou fração. Não há dado público sobre quantas cumprem, quantas desconhecem a obrigação, ou quanto tempo a rotina consome.

Internacionalmente, a American Psychological Association conduz anualmente o Practitioner Pulse Survey, cuja edição de 2024 (N = 853) registrou que 53% dos psicólogos não dispunham de vagas para novos pacientes. Não existe instrumento brasileiro comparável.

Sobre quem conduz

O pesquisador responsável é economista e contador, com pós-graduação em Gestão, e atua com profissionais autônomos e prestadores de serviço. O recorte deste levantamento — receita, inadimplência, precificação, carga fiscal e tempo administrativo — é matéria da sua formação e da sua prática profissional, o que sustenta a competência técnica para conduzi-lo. **Não há vínculo institucional nem financiamento externo:** trata-se de levantamento independente, com protocolo público e pré-registro depositado antes da coleta.

Quadro comparativo disponível

país	fonte	N	quando	indicador comparável
EUA	APA, <i>Practitioner Pulse Survey</i>	853	set/2024	53% sem vaga para novos pacientes
Austrália	Australian Psychological Society	n/d	fev/2022	33% com agenda fechada (era 1% antes da pandemia); 75% mantêm lista de espera
Reino Unido	British Psychological Society	5.700 +	nov/2019	40% esgotados ao fim do dia; 14% consideravam deixar a profissão
Brasil	—	—	—	não existe

O dado australiano provém de cobertura jornalística da pesquisa da APS, sem N divulgado na fonte consultada; será tratado como contexto até que o relatório original seja obtido. A pesquisa britânica é anterior à pandemia, que a série australiana indica ter sido uma quebra estrutural.

Termos de busca empregados, sem retorno do dado: gestão de consultório psicologia · dificuldades psicólogo autônomo · precarização trabalho psicólogo · honorários psicologia precificação · inadimplência consultório psicologia · taxa de faltas psicoterapia Brasil · lista de espera consultório particular psicologia · renda psicólogos consultório particular.

2 · Objetivos

Geral. Descrever as condições administrativas e financeiras do exercício da Psicologia clínica em consultório particular no Brasil e verificar se a prática brasileira apresenta o mesmo padrão de saturação de demanda documentado nos Estados Unidos, na Austrália e no Reino Unido.

Específicos.

- Estimar a frequência de sessões marcadas e não realizadas, e o destino desses horários.
- Descrever as práticas de cobrança, política de faltas e a proporção de faltas efetivamente cobradas.
- Medir a distância entre os honorários praticados e a tabela de referência CFP/Fenapsi, e a periodicidade de reajuste.
- Estimar o grau de adesão ao Recibo Eletrônico de Serviços de Saúde e o tempo despendido com obrigações fiscais.
- Estimar o tempo despendido em atividades não assistenciais.
- Ordenar, por escolha forçada, os problemas percebidos como mais custosos no exercício da prática.
- Caracterizar a demanda não atendida — pessoas que procuram atendimento sem que haja horário disponível.
- Comparar, por meio de itens harmonizados, a disponibilidade de agenda e a manutenção de lista de espera no Brasil com os indicadores publicados por APA (2024), APS (2022) e BPS (2019).

3 · Método

Delineamento. Estudo transversal, descritivo, de levantamento (*survey*), com aplicação de questionário autoaplicado on-line.

População e amostra. Psicólogas e psicólogos com registro ativo em Conselho Regional de Psicologia que realizem atendimento clínico particular no Brasil. Amostragem **não probabilística por conveniência**, com divulgação por múltiplos canais independentes — conselhos regionais, institutos de formação, supervisores clínicos, comunidades profissionais e redes sociais. **O canal de origem é registrado para cada respondente**, permitindo análise estratificada e detecção de vies de recrutamento. Meta: 250 questionários completos.

Instrumento. Questionário estruturado de 50 itens numerados, sendo 7 condicionais, tempo médio estimado de 9 minutos, em oito blocos. Quatro decisões de desenho merecem registro:

- **Bloco aberto precedendo bloco fechado, sem retorno.** As quatro questões abertas iniciais são apresentadas e gravadas antes de qualquer lista de alternativas, e não podem ser editadas depois. A medida busca preservar a

resposta espontânea da contaminação pelas categorias oferecidas adiante.

- **A primeira questão aberta não é enunciada em termos de problema.** Ela solicita a reconstrução do último dia de atendimento — o que a respondente fez fora das sessões, do início ao fim do dia —, sem qualificação de valência. As três seguintes perguntam por incômodo, por solução improvisada e por preocupação. A ordem é deliberada: questões enunciadas em termos de problema recuperam apenas aquilo que a respondente já classificou como problema, e deixam fora a carga de rotina normalizada, que é justamente o objeto que um levantamento de descoberta precisa alcançar.
- **Ausência de escalas de intensidade.** O instrumento não contém escalas do tipo Likert de incômodo. As medidas são de contagem, ancoradas em episódio recente (“na semana passada”, “nos últimos três meses”), de comportamento declarado, e de escolha forçada.
- **Escolha forçada com dezesseis itens em ordem aleatória, mais item residual aberto.** A ordenação de três entre dezesseis obriga à renúncia e produz ordenação, o que escalas de intensidade não produzem. **Seis dos dezesseis itens referem-se a problemas de natureza não administrativa** — captação de clientes, esgotamento, isolamento profissional, custo de formação continuada, insegurança quanto a normas éticas e mensagens de pacientes fora do horário de sessão —, incluídos em igualdade de condições para que possam prevalecer sobre os demais. Um **décimo sétimo item, residual e de texto livre** (“outra coisa — qual?”) é apresentado sempre na última posição: sem ele, a medida principal só poderia ordenar categorias previamente formuladas pelos pesquisadores. **A proporção de respondentes que o escolhe é tratada como medida de validade de conteúdo da lista**, com consequências fixadas no pré-registro.

Itens harmonizados. Cinco itens foram redigidos para permitir comparação direta com os instrumentos internacionais: aceitação de novos pacientes, manutenção de lista de espera, recusa de procura por indisponibilidade, consideração de deixar a atuação clínica e frequência de esgotamento ao fim do dia. **Os dois últimos constituem exceção declarada à regra de ausência de escalas:** são escalas de frequência de estado, não de intensidade de incômodo, e foram importadas dos instrumentos de referência precisamente para serem comparáveis.

Coleta. Plataforma própria, em domínio da instituição responsável. Registro anônimo em banco de dados sob controle da instituição.

Análise. Estatística descritiva; medianas e intervalos interquartis para variáveis de contagem; tabelas cruzadas por estrato — canal de origem, modalidade de atuação, disponibilidade de agenda e abordagem teórica. As respostas abertas serão submetidas a **análise de conteúdo com categorias construídas a posteriori**, a partir do corpus, e o ranking emergente das respostas abertas será **comparado ao ranking da escolha forçada** — a divergência entre ambos é tomada como estimativa do efeito de lista. Onde as distribuições do CensoPsi 2022 permitirem, serão calculados pesos de pós-estratificação por região, gênero e tempo de formação.

Critérios de exclusão. Duração de preenchimento inferior a 120 segundos; inconsistência aritmética nas questões de decomposição.

4 · Aspectos éticos

Anonimato. O instrumento **não coleta nome, e-mail, CPF, número de registro profissional nem qualquer identificador direto**. As respostas são analisadas exclusivamente de forma agregada.

Separação entre pesquisa e contato. Ao final do questionário, o participante pode, opcionalmente, acessar **formulário separado** para receber o relatório ou manifestar interesse em entrevista. Esse formulário não é vinculado às respostas, e não há meio técnico de associá-los.

Enquadramento normativo. Trata-se de pesquisa de opinião com participantes não identificados, **dispensada de registro e avaliação pelo sistema CEP/CONEP** nos termos da Resolução CNS nº 510/2016, art. 1º, parágrafo único, inciso I.

Proteção de dados. O tratamento observa a Lei nº 13.709/2018. O consentimento é colhido de forma expressa na abertura, com informação sobre finalidade, natureza anônima, destino dos dados e publicidade do relatório. Controlador dos dados: o pesquisador responsável. Base legal: consentimento do titular (art. 7º, I), colhido de forma expressa e informada, com coleta anônima e sem qualquer identificador direto.

Riscos e benefícios. Riscos mínimos, não superiores aos da vida cotidiana. O questionário aborda a organização do trabalho, não a experiência clínica com pacientes. Benefício direto: acesso ao relatório; benefício coletivo: produção de dado inexistente sobre a categoria.

5 · Conflito de interesse

Declarado de forma integral, na abertura e no encerramento do instrumento, e no relatório final: o pesquisador responsável é sócio da Produtize, que desenvolve um sistema de gestão para consultórios de psicologia, e o levantamento é custeado por ela. Nenhum item do instrumento faz referência a produto, marca ou solução comercial — o instrumento completo é publicado junto ao protocolo, antes da coleta, e pode ser conferido. O produto da pesquisa é o relatório agregado, de acesso público e gratuito, publicado qualquer que seja o resultado. A hipótese central (H6) contraria o interesse comercial do responsável, e está registrada com data anterior à coleta.

6 · Contribuição esperada

- **Descritiva.** Primeira caracterização nacional das condições administrativas e financeiras do exercício da clínica privada, sobre uma modalidade que concentra 35,5% da categoria.
- **Comparativa.** Primeira comparação entre o padrão brasileiro de disponibilidade de agenda e demanda não atendida e os padrões documentados nos EUA, Austrália e Reino Unido.
- **Metodológica.** Ao aplicar bloco aberto irreversível antes de bloco fechado e comparar os dois rankings resultantes, produz estimativa empírica do **efeito de lista** em pesquisa sobre condições profissionais — achado que independe do resultado substantivo.

7 · Produtos e devolutiva

- **Relatório completo**, publicado em acesso aberto, sem cadastro, com o instrumento em anexo, os N por estrato e as limitações declaradas.
- **Recortes regionais**, disponibilizados aos Conselhos Regionais que colaborarem com a divulgação.
- **Recorte fiscal**, disponibilizado aos escritórios de contabilidade colaboradores.
- **Base agregada e anonimizada**, publicada junto ao relatório.
- Submissão a periódico da área, conforme a qualidade do dado obtido.

8 · Limitações declaradas

Amostra **não probabilística**, sujeita a viés de autosseleção e a sobre-representação de perfis mais organizados, mais conectados e mais interessados em tecnologia. Os dados são **autorrelatados** e sujeitos a viés de memória, ainda que a ancoragem em episódio recente busque atenuá-lo. **Nenhuma inferência causal é possível.** O estudo descreve; não explica.

Anexo · Pré-registro

A ser depositado no Open Science Framework antes da primeira coleta.

Hipóteses

#	hipótese	como se refuta
H1	A mediana de pessoas em espera por horário é inferior a 3 entre as respondentes	mediana ≥ 3
H2	Menos de 40% das faltas e desmarcações em cima da hora são efetivamente cobradas	$\geq 40\%$ cobradas
H3	Mais de 50% praticam honorário abaixo do menor valor da tabela de referência CFP/Fenapsi (R\$ 213,93)	$\leq 50\%$
H4	Mais de 30% não emitem pelo Receita Saúde ou desconhecem a obrigatoriedade	$\leq 30\%$

H5	O item “ conseguir pacientes novos ” figura entre os três mais custosos com frequência igual ou superior ao item “ horário que fica vazio ”	frequência inferior
H6	A proporção com a agenda fechada a novos pacientes é inferior em ao menos 15 pontos percentuais à documentada nos EUA (53%, N=853)	diferença menor que 15 p.p.
H7	A mediana da conjunção — antecedência suficiente e falta não cobrada e alguém disponível, no mesmo episódio — é menor que 1 por trimestre	mediana ≥ 1

Ressalva de fonte, registrada antes da coleta. O parâmetro norte-americano foi verificado na publicação original (APA Practitioner Pulse 2024, N=853). O parâmetro australiano provém de cobertura jornalística do relatório da APS, sem amostra divulgada, e será substituído pelo dado primário ou omitido da comparação caso o relatório original não seja obtido até o fechamento da análise.

H6 é a hipótese central do estudo. Se confirmada, a saturação de demanda que caracteriza a prática privada em países anglófonos não se reproduz no Brasil — achado relevante para acesso, renda e sustentabilidade da prática autônoma. Se refutada, o mercado brasileiro se aproxima do padrão internacional. **Ambos os resultados são publicáveis.**

H5, H6 e H7 são as hipóteses que o desenho existe para poder confirmar. Ela contraria a expectativa inicial de quem conduz o estudo, e sua confirmação implicaria que o problema percebido como mais custoso pela categoria é de **demanda**, e não de **gestão de agenda**.

H7 decide sozinha uma feature. Todas as demais medem margens separadas — quantas faltas, quantas cobradas, quantos esperando. A H7 mede o **produto delas**: em quantos episódios as três condições necessárias para reocupar um horário coexistiram. É possível haver muitas faltas e muita gente numa lista sem que as duas coisas se encontrem uma única vez.

Plano de análise, fixado antes da coleta

A ordem é obrigatória. A codificação do material aberto — bloco 1, texto do item residual do bloco 7 e bloco 8 — é realizada **antes de qualquer inspeção do ranking fechado**, e por quem não tenha visto os resultados fechados. A ordem inversa faria as categorias fechadas guiarem a leitura das abertas, e o instrumento perderia a única parte capaz de produzir achado fora das hipóteses.

1. **Codificação aberta, cega ao bloco 7.** Categorias construídas a posteriori a partir do bloco 1, do texto do item residual e do bloco 8, com dupla codificação em subamostra de 20% e índice de concordância reportado.
2. Mediana, P25 e P75 de pessoas em espera; proporção de respondentes com zero.
3. Razão entre faltas cobradas e faltas ocorridas, no agregado e por respondente.
4. Distribuição de honorários contra os três pontos da tabela CFP/Fenapsi.
5. Frequências de adesão ao Receita Saúde, com destaque para a categoria “não sabia que era obrigatório”.
6. Ranking ponderado da escolha forçada (1º = 3 pontos, 2º = 2, 3º = 1), com o ranking do que “não é problema nenhum” reportado em paralelo.
7. Cruzamento do ranking por disponibilidade de agenda, por modalidade e por canal de origem.
8. Ranking emergente das respostas abertas contra o ranking da escolha forçada.

Regra de falha declarada do instrumento

Fixada antes da coleta, e reportada mesmo quando desfavorável:

- (i) Categoria emergente que apareça em **15% ou mais** do material aberto e não possua item correspondente na lista fechada do bloco 7 é reportada como **falha do instrumento**, nomeada, e apresentada antes do ranking.
- (ii) Se o item residual for escolhido por **mais de 20%** das respondentes, o ranking dos demais itens é reportado como **provisório** e a lista fechada é declarada insuficiente para descrever a categoria.
- (iii) Entre 10% e 20% de escolha do residual, o relatório nomeia o domínio faltante sem invalidar o ranking.

*Toda lista fechada de dificuldades é um conjunto de pressupostos de quem a escreveu. Estas regras existem para que o levantamento consiga **registrar o próprio erro de desenho** em vez de o dissolver num ranking bem comportado.*

Critérios de parada e de publicação

- **N mínimo para publicação como estudo: 120 completos.** Abaixo disso, o resultado é divulgado como levantamento exploratório, e a palavra “estudo” não é utilizada.
- Coleta encerrada em [data] ou ao atingir 250 completos, o que ocorrer primeiro.
- **O relatório é publicado independentemente do resultado**, inclusive se refutar todas as hipóteses.

Referências

- BENTIVI, D. R. C.; PORTO, J. B.; DIAS, L. M. M. Características da inserção no mundo do trabalho e condições para o exercício profissional. In: CFP. *Quem faz a psicologia brasileira?* v. 1. Brasília: CFP, 2022. p. 159–174.
- COSTA, V. C. A.; OLIVEIRA, I. F. Condições de trabalho e vida de profissionais de psicologia no Brasil: contradições da Nova República. *Cadernos de Psicologia Social do Trabalho*, v. 28, e-222584, 2025. DOI 10.11606/issn.1981-0490.cpst.2025.222584.
- CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA; FENAPSI. *Tabela de honorários*. Vigência 1º jun. 2024.
- DeFIFE, J. A.; CONKLIN, C. Z.; SMITH, J. M.; POOLE, J. Psychotherapy appointment no-shows: rates and reasons. *Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training*, v. 47, n. 3, p. 413–417, 2010.
- LOUMIDIS, K. S.; SHROPSHIRE, J. M. Effects of waiting time on appointment attendance with clinical psychologists and length of treatment. *Irish Journal of Psychological Medicine*, v. 14, n. 2, p. 49–54, 1997. DOI 10.1017/S0790966700002986.
- AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION. *2024 Practitioner Pulse Survey*. Washington, DC: APA, 2024.
- AUSTRALIAN PSYCHOLOGICAL SOCIETY. Pesquisa com membros sobre disponibilidade de agenda, 2022. [Relatório original a obter; dado reportado por ABC News, 23 fev. 2022.]
- BRITISH PSYCHOLOGICAL SOCIETY. *Member survey on working conditions*. Leicester: BPS, 2019.
- BRASIL. Resolução CNS nº 510, de 7 de abril de 2016.
- BRASIL. Receita Federal. Instrução Normativa RFB nº 2.240, de 11 de dezembro de 2024.
- BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD).

Protocolo elaborado em 31 de agosto de 2026. Alterações posteriores ao início da coleta serão registradas como emenda datada, com o texto original preservado.